

EDUCACIONAL

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE ENTENDER O PENSAMENTO KLEINIANO

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 1Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

O mundo interno: um colorido de fantasias e de objetos



1

introdução

Neste módulo, exporemos alguns dos principais conceitos da teoria kleiniana. Eles fornecerão uma base para quem desejar partir para uma leitura mais ampla dos textos de Klein.

Atenção

Você deve chegar ao final compreendendo:

- » O conceito de *Fantasia* para Klein;
- » O conceito de *Objeto Interno* e a realidade psíquica na visão kleiniana;
- » Os mecanismos esquizoparanoides e seu papel do desenvolvimento do psiquismo;
- » Os mecanismos depressivos e seu papel no desenvolvimento humano.

2

O Mundo Interno: um colorido de fantasias e de objetos

Melanie Klein, ao empreender a análise de crianças, adquiriu amplo conhecimento do funcionamento emocional da psique infantil. Seu entendimento do mundo interno dos pequenos pacientes também auxiliou no enriquecimento da compreensão da personalidade adulta – com seus núcleos sedimentados, que operariam por toda a vida. Isso porque a psicanalista defendia que a estrutura arcaica das emoções infantis tinha participação fundamental no desenvolvimento da mente dos adultos, levando-se inclusive em conta as experiências datadas de um período pré-verbal.

A investigação que Klein realizou da vida emocional dos bebês permitiu o vislumbre das atividades mentais primitivas e a possibilidade de dar palavras aos elementos mais primevos e aos núcleos mais infantis da personalidade. Tais núcleos internos são expressão do funcionamento emocional dos pacientes e base de significação para as vivências deles no campo das relações objetais. Sigamos algumas ideias que surgem desta busca de entendimento empreendida por Klein.

Uma concepção muito importante na teoria kleiniana é a noção de fantasia. Klein dedicou considerável atenção ao papel da fantasia inconsciente dinâmica na vida psíquica da criança. Em sua obra, o conceito freudiano de fantasia inconsciente recebeu maior destaque, ampliando-se.

Perscrutar a origem, a estrutura e as funções da fantasia sempre foi um desafio constante para os psicanalistas. Enfrentar a questão da fantasia inconsciente é estar no cerne da composição da psique, por causa de sua relação com os instintos, os objetos, a simbolização e a estruturação das trocas entre a realidade psíquica e a realidade exterior. Em especial, o mundo fantasmático que surge na obra de Melanie Klein é, para muitos, inicialmente espantoso. Povoado de objetos internos e complexas tramas – onde a cobiça, a inveja, a vingança, o medo, a gratidão, o mais extremo amor e tantos outros sentimentos vão entrando em jogo na vida do *enfant* –, esse mundo interno que o sistema kleiniano descreve é fruto de uma longa experiência clínica, e não de uma dedução teórica que se constrói a partir do vazio.

Como nos afirma Tanis (2009, p.69), o universo da fantasia inconsciente, da forma como Klein o concebe, é uma linguagem corporal muito viva e extremamente concreta. Para a criadora da psicanálise com crianças, existe uma continuidade muito clara entre o corpo e a fantasia, por isso é que Klein entenderá que a fantasia é, desde suas origens, inconsciente – iniciando sua ação antes mesmo da repressão. Nesse sentido, sua pesquisa das manifestações da fantasia abarca inclusive os processos psíquicos pré-verbais, o que mais uma vez denota a concepção de uma organização do psiquismo sofisticada e atuante desde os primeiros meses de vida.

Importante compreender também que a fantasia não é a contraposição a uma falta de sentido da realidade. Não é uma oposição negativizada da razão. Na verdade, para Klein, não é possível conceber a razão sem o colorido que lhe atribui a vida emocional. As emoções deformam as percepções e as imagens que formamos do mundo, determinando a tonalidade dos elementos que chegam a nossa mente partindo do mundo externo. A razão é, portanto, inevitavelmente permeada pela fantasia. “O significado emocional das experiências não nos é dado por uma faculdade independente idealizada como razão, capaz de operar fora de uma zona de conflitos, mas pela organização das emoções que vão colorir nossa razão, transformando-a em crenças e percepções”. (BARROS, E.M.R; BARROS, E.L.R, 2009, P.20).

Sendo assim, a fantasia e a realidade passam a constituir um dueto indissolúvel na composição da subjetividade. O que determinaria o caráter do psiquismo do indivíduo seria a natureza de suas fantasias inconscientes e o modo como elas se relacionariam com a realidade externa.

Mas o que afinal seria, para Klein, a fantasia? Segundo Segal (1973), a fantasia pode ser considerada como o representante psíquico, a expressão mental dos instintos. Entende-se, portanto, que o inconsciente seria habitado, sobretudo, por fantasias – entendidas no sentido que Klein a elas atribuiu: o de representantes mentais instintuais.



Logo, na teoria kleiniana, as ideias que representam os instintos são as fantasias primitivas originais. Já no início da vida, a atuação dos instintos seria transposta para a vida mental com fantasias de satisfação. Nelas, o instinto aparece como sendo satisfeito por um objeto apropriado. As fantasias inconscientes, na medida em que datam de um período pré-verbal, são experimentadas como sensações, e depois, tomam a forma de imagens plásticas – imagens visuais, auditivas, sinestésicas, táteis, gustativas, olfativas... Os sentimentos (desejos, angústia, amor), assim como as defesas erigidas para com eles lidar, também serão traduzidos pelo pequeno indivíduo como fantasias inconscientes.

Para Tanis (2009), um dos pontos essenciais que resulta das pesquisas de Melanie Klein é a percepção do aspecto originário das fantasias inconscientes. As fantasias não teriam origem em um conhecimento estruturado a partir do mundo externo, sua fonte seria interna: os impulsos instintivos. Portanto, a originalidade da ideia kleiniana não residiria no fato de existirem representações protomentais das ações dos instintos, mas da suposição de que ações, por exemplo, de natureza destrutiva – como dilacerar e devorar – já estariam contidas instintivamente no impulso, de maneira que a fantasia precederia a experiência. Sobre isso, Isaacs (1952/1986 p.108) exemplifica:



A fantasia de que os seus impulsos apaixonados destruirão o seio materno não exige que o bebê tenha realmente visto os objetos devorados e destruídos e chegue, depois, à conclusão de que também poderia fazê-lo. Esse anseio, essa finalidade, essa relação com o objeto, é inerente ao caráter e direção do próprio impulso e seus afetos correlativos.

Apesar desse entendimento, a realidade externa em nada diminui sua importância na estruturação psíquica do sujeito. Assim é que também Isaacs (1952/1986, p. 107) ressaltará:



Portanto, as primeiras fantasias promanam de impulsos físicos e estão interligadas com sensações e afetos físicos. Expressam primordialmente, uma realidade interna e subjetiva;

contudo, desde o princípio, estão vinculadas com uma experiência concreta, mais ou menos limitada e estreita, da realidade objetiva.

Essa teorização é o que permite que se presuma a existência de fantasias lá desde o nascimento, pois, já ali, os instintos estariam em ação. A primeira fome, acompanhada pela vivência instintual que busca satisfazê-la, será seguida pelo fantasiar de um objeto capaz de dar resposta ao anseio aí gerado. Dessa forma, pode-se perceber a vinculação entre os conceitos de fantasia e de objeto interno.

Tomemos como exemplo o primeiro objeto interno do bebê, o seio alimentador. Ele pode adquirir tanto qualidades boas como qualidades más, de acordo com a faceta que vai se apresentando para a criança a cada momento. O *enfant* pode representar figurativamente a fome como presença concreta de um objeto que o frustra, sendo encarada como fruto da ação concreta de algo realmente existente dentro dele e vivenciada como uma figura persecutória. Nesse sentido, o seio será interpretado como bom, quando alimenta o bebê, ou como mau, quando não o satisfaz.

Esse também é um bom exemplo para pensar o conceito de objetos parciais. O bebê, de início, não teria a capacidade de perceber a mãe como um todo unificado. Apesar disso, já seria capaz de estabelecer suas primeiras relações objetais. Mas, como seu ego primitivo ainda careceria de coordenação, essas relações seriam estabelecidas apenas com partes do corpo da mãe – que, no entanto, seriam vislumbradas pelo bebê como constituindo um todo. Essas partes do corpo constituiriam os denominados objetos parciais (seio, fezes, pênis...).

Trata-se de objetos precipuamente emocionais, o que implica que a percepção de sua existência material importa bem menos do que sua função enquanto objeto de satisfação. Por isso mesmo, suas características intrínsecas, como entidade exterior ao bebê, não é o que dá o tom à relação. O que entra em jogo é o modo como o bebê se direciona para ele, com suas necessidades instintuais e fantasias. O objeto parcial será vivenciado como um objeto que gratifica ou que frustra.

O objeto parcial não tem, portanto, características separadas e independentes do indivíduo que o sustenta. Por esse motivo, ele possui contornos muito mais narcísicos do que propriamente objetais. Apesar de sua natureza narcísica, o bebê comporta-se com ele como se estivesse em uma relação com um objeto separado e diferenciado de si. “De modo animístico, o bebê atribui-lhe sentimentos, qualidades e intenções que precisam ser sentidos como alheios ao seu *self*”. (COELHO JÚNIOR; SIGLER, 2009, p. 78)

E, dessa maneira, o bebê irá projetar sobre esse objeto parcial – que ele, inicialmente, encara como um todo constituído – suas fantasias inconscientes. De acordo com Simon (2009), a projeção do instinto de vida resulta na imagem de um objeto de gratificação, que ama e protege. Já a projeção do instinto de morte compõe a imagem de um objeto frustrador, que rejeita e ameaça. Essas imagens criadas são, posteriormente, introjetadas e servirão de material para a composição do mundo interno do bebê. Diversas projeções e introjeções se seguirão às primeiras, de forma que a estrutura do ego, do superego, assim como a estrutura de diversos objetos internos com quem essas instâncias se relacionarão, serão, assim, formadas.

Nesse início, no entanto, o que ocorre é que esses objetos parciais iniciais montam um cenário interno de elementos fantásticos que pode ser, ora imensamente generoso, ora extremamente cruel. O bebê experimentará, assim, nos seus primeiros meses, uma angústia persecutória (ou “paranóide”). Isso impulsionará o pequeno indivíduo a fazer uso de alguns mecanismos

defensivos. O principal deles – a clivagem – permite que o bebê divida o objeto originário em objeto mau e objeto bom (“seio mau” e “seio bom”, por exemplo). Depois, fazendo uso da projeção e da idealização, o bebê expulsa os objetos persecutórios (evitando, assim, ser por eles destruído) e idealiza os bons objetos (para que eles o protejam das ameaças de aniquilamento).

Com o desenvolvimento, no entanto, começa a imperar no bebê uma tendência à síntese. Ele começa a ser capaz de perceber o seio como um objeto total. Dessa maneira, os objetos bons e os objetos maus principiam um processo de integração que os comporá como objetos totais. Assim, progressivamente o bebê vai integrando seus objetos, e o mundo passa a ser habitado por pessoas complexas e cheias de contradições. O *enfant* passa a vivenciar a ambivalência (ama e odeia o mesmo objeto), já que, a partir daí, passa a conviver com as imagens de seu pai, de sua mãe e do casal parental de forma integrada.

Coelho Júnior e Sigler (2009) elucidam que o objeto total não possui mais uma natureza narcísica, pois não se define exclusivamente pelos sentimentos do bebê, contendo características próprias. O bebê pode experimentar, então, uma maior estabilidade nos seus sentimentos pelos objetos – sem vivenciar variações muito bruscas como nas fases anteriores. Despontam, também, a preocupação e o interesse pelos objetos.

É nessa fase que, levando-se em conta a característica de onipotência das fantasias, o bebê pode desenvolver a crença de que seu ódio é capaz de destruir os objetos amados. Essa é a origem do sentimento de culpa e de arrependimento, pois a criança acredita que pode ter causado um dano aos seres reais. Isso acarreta “um estado de luto pelo mundo destruído, interna e externamente, vivido com muita dor e remorso, muito semelhante ao do adulto quando perde um objeto amado” (SIMON, 2009, p. 29).

O amor e a culpa pelo prejuízo causado mobilizariam um mecanismo de reparação por meio do qual a criança abriria mão de sua destrutividade e iniciaria um movimento de restauração do objeto amado, processo de fundamental importância para o bom relacionamento humano e a evolução da cultura. Eros imperaria sobre Thanatos.

Conclui-se, portanto, que os objetos internos – ideia central do sistema kleiniano – integram o conjunto de fantasias que são a base do nosso mundo psíquico.

Esse mundo psíquico, como já foi dito, também recebe as influências das experiências concretas. Desde o nascimento, o indivíduo tem de lidar com as exigências reais, experimentando diversas situações de gratificação e frustração. Essas experiências vão tomando sua forma dentro do movimento incessante de trocas entre fantasias inconscientes e realidade. Um campo retroalimenta o outro, e ambos vão se constituindo em lentes por meio das quais o indivíduo enxergará e se relacionará com o mundo.

Assim, assistimos a uma inter-relação constante travada entre fantasia e realidade. A fantasia inconsciente influencia e altera a percepção e a interpretação da realidade. O inverso também ocorre: a realidade exerce seu afeito sobre a fantasia inconsciente e é vivida, incorporada e atua sobre a própria fantasia.

A compreensão desta inter-relação também está no fundamento das discussões sobre a importância do ambiente no desenvolvimento da criança. Não há como negar o papel que o ambiente exerce tanto no início da infância como em seus anos posteriores, mas é preciso também atentar para a função das fantasias e das ansiedades persecutórias – que existirá para

além de o ambiente ser realmente bom ou mau. Como afirma Seggal (1973), a importância do fator ambiental só pode ser avaliada em relação ao que ele significa nos termos dos próprios instintos da criança. Ou seja, não há como fazer uma avaliação “pura” sobre a influência do ambiente sem levar em conta a atuação das forças instintuais operantes na criança.

Importante

Importante lembrar ainda que, nos primeiros processos mentais, a fantasia é representante psíquica dos instintos libidinais e destrutivos. Mas, no desenvolvimento mental da criança, a fantasia cedo se converterá também em uma defesa contra a ansiedade – um meio de inibir e controlar os impulsos instintivos – assim como será, além do mais, a expressão dos desejos reparadores. Isso porque as fantasias servem a vários propósitos, como por exemplo: negação, renovação da segurança, controle, onipotente... (ISAACS, 1952/1986).

Um exemplo é a capacidade que a criança tem de fantasiar que está tendo suas necessidades saciadas. Dessa maneira, ela se defende das privações (tanto externas como internas), evitando, assim, as sensações desencadeadas pela frustração.

Esse mecanismo é fundamental para que se entenda a função que a fantasia tem de adiar a descarga da libido – auxiliando, no entanto, na diminuição das tensões geradas pelos instintos, pela ansiedade e pela culpa (na medida em que é uma via de realização de desejo substitutiva). É nesse papel que ela se configura como ferramenta para a passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. Logo, ela prepara o indivíduo para o desenvolvimento das funções mentais mais elevadas, como, por exemplo, o pensar.

As fantasias também podem ser usadas como defesa contra outras fantasias. Segal (1973) fornece como exemplo típico desse mecanismo as fantasias maníacas, cuja principal finalidade é repelir fantasias depressivas subjacentes.

E foi partindo da teorização de todas essas funções que a fantasia desempenhava na vida psíquica do ser humano que Melanie Klein pôde sustentar que o “nada”, que alguns acreditavam constituir a mente do bebê, não era um vazio. Já se encontrava preenchido por forças instintuais, que ameaçavam a integridade do pequeno indivíduo, gerando uma ansiedade de aniquilamento que o forçava a estabelecer intenso intercâmbio entre seu mundo interno e o mundo externo. Retomemos algumas das funções da fantasia.

- » Representante psíquico das forças instintuais;
- » Defesa contra as privações, a ansiedade e a culpa;
- » Base para a formação dos objetos internos, do Ego e do Superego;
- » Ferramenta que auxilia na passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, permitindo o desenvolvimento de funções mentais mais elevadas.

Estabelecidos esses conceitos básicos, nos é possível partir para algumas inovações teóricas que Klein propôs a partir de sua clínica.

EDUCACIONAL

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE ENTENDER O PENSAMENTO KLEINIANO

UNIDADE 4 | CAPÍTULO 2Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

A Posição Esquizoparanoide



1

introdução

Neste capítulo e no subsequente apresentar-se-á, respectivamente, os conceitos de posição esquizoparanoide e posição depressiva. Para isso, no entanto, faz-se precípua elucidar, de saída, o que afinal significa posição na teoria Kleiniana.

Para Segal (1973), a posição esquizoparanóide e a posição depressiva podem ser consideradas momentos do desenvolvimento do psiquismo humano. Elas representariam subdivisões do estágio oral. Na posição esquizoparanoide, em funcionamento nos primeiros meses de vida do bebê, a criança não perceberia a totalidade de seus primeiros objetos (por exemplo, a “mãe” e o “pai”). As relações do bebê seriam, na verdade, travadas com objetos parciais (por exemplo, o seio), prevalecendo os processos de divisão e as ansiedades paranoides. Em seguida a esse momento, surgiria a posição depressiva, marcada pela percepção da mãe como objeto total. Nela, emergiria a integração dos objetos, assim como os sentimentos correlatos de ambivalência, ansiedade depressiva e culpa.

Mas por que usar, então, o termo “posição” ao invés de “estádio”? Porque Melanie Klein desejava demarcar a diferença entre essas duas concepções, na medida em que as posições seguem outro tipo de funcionamento. Elas não são, por exemplo, ultrapassadas cronologicamente pela criança, assim como aconteceria com os estágios ou as fases. Elas têm uma natureza estrutural. Representam determinados tipos de configurações assumidas pelas relações de objeto, ansiedades e defesas que o indivíduo levaria consigo por toda a vida, sendo fundamentais para entender o funcionamento psíquico humano.

Portanto, a posição depressiva nunca supera, de todo, a posição esquizoparanóide. Sempre há uma via de interação entre os mecanismos de ambas, e não será raro que, ao se defender das ansiedades próprias à posição depressiva, o indivíduo regride às manifestações

esquizoparanoides, estando sempre a oscilar entre as duas posições. Não se tratam, dessa maneira, de fases que serão superadas, mas de mecanismos que o sujeito usa para interagir com o seu mundo interno e com o mundo externo.

Logo, é necessário compreender que “O conceito de ‘posição’ não entra em conflito com o conceito de ego, superego e id, mas tem como teor definir a estrutura real do superego e do ego, bem como o caráter de seus relacionamentos nos termos das posições esquizoparanoides e depressiva”. (SEGAL, 1973/1975, p12)

Definida, assim, a concepção de posição, podemos passar à descrição dos fenômenos que caracterizam a posição esquizoparanóide. Para tanto, acompanharemos de perto as elaborações de Klein sobre esse tema em seu texto de 1946, “Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizóides”.

Klein principia seu escrito anunciando que tratará da importância dos mecanismos esquizoparanoides, sobre os quais teria refletido muito a partir de suas experiências clínicas. Estes diriam respeito às mais antigas ansiedades experimentadas pelo bebê, deixando antever o funcionamento arcaico do psiquismo humano.

Klein levanta a hipótese de que, no início da vida, o bebê se depararia com ansiedades primitivas que impulsioniariam o ego a desenvolver mecanismos de defesa específicos. Esse movimento teria uma profunda influência sobre o desenvolvimento em todas as suas nuances, incluindo as que abarcam o ego, o superego e as relações objetais.

Esse ponto retomaria a defesa de Klein da ideia de que, desde o princípio da vida, já existiriam as relações objetais, e de que o primeiro objeto da criança seria o seio da mãe. Ela o dividiria em seio “bom” (gratificador) e seio “mau” (frustrador). Tal divisão resultaria numa separação nítida entre amor e ódio. A clivagem do objeto, assim como a utilização dos mecanismos de introjeção e projeção (que compõem diversas interações entre si) e as situações internas e externas moldelariam as relações objetais do pequeno indivíduo. “Esses processos participariam na formação do ego e superego, preparando o terreno para o estabelecimento do complexo de Édipo na segunda metade do primeiro ano de vida”. (KLEIN, 1952/1986, p.314)

Eis os processos psíquicos que ocorreriam no início da vida do bebê: quando o impulso de morte volta seu investimento contra o primeiro objeto – o seio materno – ele assume a forma de fantasias de ataques sado-orais, progredindo, posteriormente para agressões generalizadas ao corpo da mãe também pelos meios sado-anais e sado-uretrais. Nos impulsos sádico-orais, a criança fantasia despojar o corpo materno de todos os conteúdos bons, esvaziá-lo de suas riquezas (seus bebês, o pênis paterno que ali estaria guardado, etc). Já as fantasias sado-anais e sado-uretrais almejariam colocar dentro da mãe os excrementos da criança (e a própria criança desejaria penetrar no corpo materno, como forma de controlá-lo por dentro).



O sadismo da criança provoca, no entanto, o medo da retaliação pelo objeto que foi tomado como alvo. Essa seria a fonte do surgimento das ansiedades persecutórias. O enfant teme ser devorado, despedaçado, envenenado. Tais medos o levarão a fazer uso de diversos mecanismos de defesa (clivagem, negação, idealização, projeção, introjeção). Se os medos persecutórios forem muito fortes e o bebê não for capaz de construir a passagem da posição esquizoparanóide para a posição seguinte – a depressiva –, dando a esta última uma resolução, o fracasso de tal processo pode acarretar um reforço regressivo dos medos persecutórios e gerar pontos de fixação que serão a base para psicoses graves. Esses fatores também serão o fundamento para a escolha da neurose.

Destrinchemos mais minuciosamente os processos envolvidos no quadro até aqui descrito:

É preciso destacar, já desde o início, que Melanie Klein defenderá a ansiedade e suas vicissitudes como sendo o motor do processo de desenvolvimento humano. Tanto é que ela focará as ansiedades como elementos fundamentais de manejo de sua clínica. Assim é que o desencadear de uma ansiedade ao longo de um processo analítico pode ser sinal de evolução e não de retrocesso no quadro apresentado pelo paciente.

O ego primitivo, para Klein, careceria de coesão, alternando entre uma tendência para a integração e uma tendência para a desintegração (fragmentação em múltiplas parcelas). A maior ou menor coesão do ego no princípio do desenvolvimento estaria na dependência da capacidade deste para tolerar as ansiedades – o que seria determinado, segundo Klein, por um fator constitucional.

Fato é que esse ego primitivo, ainda que carente de coesão, já possuiria algumas funções próprias de um ego mais avançado. Entre elas, uma fundamental: dominar a ansiedade.

A ansiedade nasceria da ação do instinto de morte dentro do organismo. Ela seria sentida como um medo de aniquilamento do eu, que se tornaria medo de perseguição. Portanto, esse medo do impulso destrutivo toma a forma de medo de um incontrolável e prepotente objeto. Somar-se-ão a esta primeira fonte de ansiedade também a ansiedade de separação e as ansiedades referentes às experiências de frustração das necessidades corporais. Também elas serão ligadas à imagem de um objeto, como se por ele houvessem sido causadas. Esses

objetos externos, por meio da introjeção, são tornados internos, reforçando o medo do impulso destrutivo.

Dentro desse quadro, o ego primitivo desenvolve defesas fundamentais para enfrentar a ansiedade que o assola. Parte do impulso destrutivo é projetado no exterior, vinculando-se ao primeiro objeto externo: o seio da mãe. Outra parte da pulsão, que permanece dentro do organismo, une-se à libido, atuando nos impulsos sádicos, e ainda uma terceira parte, que não alcança seu propósito nos dois caminhos anteriormente citados, permanece no organismo e continua a gerar a ansiedade de ser destruído interiormente. Essa ansiedade gera no ego uma tendência à fragmentação.

Sendo assim, o ego primitivo, em seu intento de lidar com o impulso de morte, divide não apenas o objeto e as relações com ele estabelecidas, o ego também se divide, na busca de dispersar o impulso destrutivo. Esses mecanismos são extremamente importantes para entender os processos esquizofrênicos.

Quanto ao impulso destrutivo que foi projetado no exterior, ele é sentido, primeiramente, como uma agressão oral. Quando o bebê se vê diante de situações de frustração e ansiedade, seus desejos sado-orais se intensificam, e ele fantasia incorporar o mamilo e despedaçar o seio. Logo, à divisão entre seio mau e seio bom, soma-se a fantasia de um seio frustrador fragmentado. Já o seio gratificador, sob o domínio da libido, permanece completo. Seria esse seio completo, o primeiro objeto interno bom, que atuaria como um ponto focal, compensando os processos de divisão e dispersão, fomentando a coesão e a integração e servindo de instrumento para a formação do ego (KLEIN, 1952/1986).

Ainda assim as vivências de frustrações e ansiedades experimentadas pela criança também poderiam leva-la a experienciar o seio bom como fragmentado, o que viria a abalar a construção da coesão do ego. Sobre isso, Klein (1952/1986, p.319) completa:



Acredito que o ego é incapaz de dividir o objeto – interno e externo – sem que uma correspondente divisão ocorra dentro do próprio ego. Portanto, as fantasias e sentimentos sobre o estado do objeto interno influem vitalmente na estrutura do ego. Quanto mais sadismo prevalecer no processo de incorporação do objeto e quanto mais se sentir que o objeto está em pedaços, atento mais o ego estará em perigo de ser dividido em relação com os fragmentos do objeto internalizado.

Somados aos mecanismos de divisão (ou clivagem) há, no entanto, outras importantes defesas utilizadas pelo ego primitivo. A idealização é uma delas. Na idealização, os aspectos bons do seio são postos em evidência como forma de criar uma proteção contra o medo do seio perseguidor. Essa exacerbação da imagem do bom seio também atende aos desejos instintivos, que fantasiam uma gratificação ilimitada, a ser fornecida por este seio ideal, inexaurível e abundante.

A negação também é um tipo de defesa – que pode aparecer inclusive conjugada à clivagem e à idealização. Nela, o ego nega a existência do objeto persecutório, assim como toda a situação de frustração e os sentimentos dolorosos a ela associados. Há, portanto, a negação de uma realidade psíquica, realizada por meio de fortes sentimentos de onipotência presentes no psiquismo primitivo. No entanto, ao realizar essa operação, o ego não está negando apenas o

objeto mau e as situações de frustração a ele associadas. O que está sendo aniquilado é, inclusive, a situação objetal. A consequência disso é que parte do ego também é aniquilada e negada nesse processo.

Esses mecanismos de defesa ainda assim não impedem que o bebê direcione ao seio seus impulsos libidinais e agressivos. Como falamos anteriormente, os ataques ao seio materno acabam se convertendo em agressões ao corpo materno, que passa a ser visto como um prolongamento do seio. Em suas manifestações orais, essas fantasias de ataque configuram-se como um sugar, esvaziar, morder e roubar todo o bom conteúdo do corpo da mãe. Nas manifestações anais e uretrais, essas fantasias são as de evacuação de substâncias venenosas (que são expelidas com ódio para serem introduzidas o corpo materno), assim como de partes más do ego (que são projetadas para dentro da mãe). Esses ataques têm o intuito tanto de causar danos como de controlar e tomar posse do objeto.

No entanto, ao projetar para a mãe as partes malquistas de seu ego, essas partes acabam por se identificar com o objeto que as recebeu. Assim, “Muito do ódio contra algumas partes do eu é agora dirigido para a mãe. Isso conduz a uma forma particular de identificação que estabelece o protótipo de uma relação objetal agressiva. Sugiro para esses processos a expressão ‘identificação projetiva’”. (KLEIN, 1952/1986, p.322)

Em situações como essa, quando ocorre a identificação de um objeto com partes odiadas do ego, e quando os impulsos projetados teriam como objetivo causar danos ou controlar o objeto, este passa a assumir a feição de um objeto perseguidor, sendo fonte de ansiedade. Além disso, se a projeção para o mundo externo de partes do ego for excessiva, ele ficará enfraquecido, pois “o componente agressivo dos sentimentos e da personalidade está intimamente associado, na mente, com o poder, potência, força, conhecimento e muitas outras qualidades desejadas”. (KLEIN, 1952/1986, p. 322)

Em um processo semelhante, as partes boas do eu também serão expelidas para o objeto externo. Assim é que os excrementos passam a ter o sentido de ofertas, presentes entregues ao corpo da mãe, e os elementos bons e amorosos do eu são projetados para dentro de outras pessoas. Aqui também essas partes boas projetadas serão identificadas com os objetos que as receberam. Dessa maneira, a identificação que surge com base nesse tipo de projeção também influencia de forma fundamental as relações objetais. “A projeção de bons sentimentos e boas partes do eu na mãe é essencial para a capacidade infantil de desenvolver boas relações objetais e integrar seu ego” (KLEIN, 1952/1986, p. 323).

Porém, aqui também há o risco de a projeção das partes boas do ego para o mundo externo se tornar excessiva, gerando no bebê o sentimento de que as partes boas da sua personalidade se escoaram e foram perdidas. Isso geraria um empobrecimento do ego e uma super idealização do objeto, sendo a mãe convertida em ego ideal. Esse processo seria expandido para outros objetos, trazendo como consequência uma dependência excessiva com relação a esses representantes externos das partes boas do próprio ego. A própria capacidade de amor parece ficar comprometida nesse processo, devido a ser o objeto amado essa projeção demasiada do próprio eu.



Outro elemento complicador que pode surgir nessa equação é que, quando a idealização do objeto e a projeção das partes boas do ego se tornam demasiadas, isso intensificará a inveja primitiva.

A inveja seria uma das primeiras e mais fundamentais emoções experimentadas pelo ser humano. Ela se estabelece sempre em uma relação dual, na qual o sujeito inveja alguma posse ou qualidade do objeto. E é importante perceber que é experienciada essencialmente em termos de objetos parciais, mesmo que persista nas relações com objetos totais. Inicia como um desejo do sujeito de ser tão bom quanto o objeto, mas, quando isso é sentido como impossível, transforma-se em desejo de danificar a bondade do objeto, por meio da projeção de partes ruins. Assim, “em fantasia, ataca o seio, cuspiendo, urinando, defecando, soltando flatos, e pelo olhar projetivo e penetrante (o mau-olhado)”. (SEGAL, 1973/1975, p. 53).

É aí que a inveja se torna nociva ao desenvolvimento do ego, pois a própria fonte de bondade na qual o bebê poderia vir a se espelhar assume feições más, e, assim, ele não tem como introjetar as partes boas de volta ao seu ego. A clivagem entre um objeto idealizado e um objeto perseguidor característica da posição esquizoparanóide fica comprometida, pois que o objeto ideal, que serviria como base para a introjeção e constituição de um foco de coesão e fortalecimento do ego, foi danificado. Assim, o indivíduo vivencia situações de desespero, na medida em que não encontra um objeto ideal para se identificar, e, portanto, não vê esperança de amor ou de qualquer ajuda. Para tornar a situação mais difícil, os objetos destruídos passam a ser fonte de perseguição interminável e de culpa. Surge, então, “um círculo vicioso, no qual a inveja impede a introjeção boa; isso por sua vez aumenta a inveja” (SEGAL, 1973/1975).

Logo, podemos concluir que “O processo de destacar as partes do eu e projetá-las em objetos é, portanto, de importância vital para o desenvolvimento normal, assim como para as relações objetais anormais” (KLEIN, 1952/1986, p. 323).

E assim também se dá com relação à introjeção. Como há pouco descrevemos, a introjeção do bom objeto é uma pré-condição para o desenvolvimento normal, pois é a base de formação do ponto focal que propiciará a coesão do ego. A existência desse bom objeto é importante inclusive para os momentos em que a criança precisa lidar com as frustrações e as ansiedades, pois ela pode usar como recurso a evasão para seu objeto ideal. Aqui, mais uma

vez, o excesso pode ser perigoso. Se o medo persecutório é muito forte e a fuga para o objeto idealizado se torna excessiva, isso dificultará as relações objetais e prejudicará o desenvolvimento do ego.

Assim, resume Melanie Klein (1952/1986, p. 325), a ação dos mecanismos de introjeção e projeção no desenvolvimento humano:



Quanto à personalidade normal, pode-se dizer que o curso do desenvolvimento do ego e das relações objetais depende do grau em que pode ser atingido um equilíbrio ótimo entre a introjeção e a projeção nos estágios iniciais do desenvolvimento. Isso, por seu turno, influi na integração do ego e na assimilação dos objetos internos. Mesmo que o equilíbrio seja perturbado e um ou outro desses processos seja excessivo, haverá sempre uma interação da introjeção e projeção.

Pode-se concluir, portanto, que, na posição esquizoparanóide, caracterizada pelas constantes permutas entre fases de integração e de desintegração do ego, o bebê experimenta ansiedades de aniquilamento, separação e frustração das necessidades que o levam a se utilizar do mecanismo de clivagem dos seus objetos primeiros e de seu próprio ego. Esse expediente, no entanto, somado a outras ações de defesa como a introjeção, a projeção, a negação, a idealização e a identificação projetiva (que operam diversas combinações entre si) dão origem a uma ansiedade persecutória, que tanto pode gerar uma maior coesão do ego e uma integração dos objetos internos e externos (o que o conduziria à posição depressiva), como pode ser excessiva e desencadear uma série de fixações e distúrbios no processo de desenvolvimento psíquico.

Fato é que, pensar o mundo com o olhar de um bebê na posição esquizoparanóide é enxergá-lo como constituído por objetos bons, que ele tenta obter, e objetos maus, que ele tenta afastar. Organizando-se assim, espera-se que ele constitua confiança no objeto que repetidas vezes o gratifica, e com ele se identifique, sentindo-se mais capaz e mais forte para enfrentar os objetos persecutórios e frustradores – que, futuramente, perceberá que pertencem não somente ao mundo externo, mas que também integram o seu eu. Esta é a função estruturante e organizadora que conduz o bebê (e conduzirá o adulto) em seu enfrentamento das vivências emocionais difíceis e fragilizadoras.

Para compreender o que Klein descreve como posição esquizoparanóide, é necessário ser capaz de vislumbrar uma experiência na qual o conhecimento de si e do mundo ainda são muito precários, e em que ainda não é possível distinguir as emoções que são suas das que são do outro. Esse é o mundo do bebê (e de alguns adultos que se fixarão ou regredirão vez por outra a essa posição). Nas experiências de frustração, tudo é vivido como ameaçador e persecutório, e, nas experiências de gratificação, tudo é perfeito e idealizado.

Sobre a presença continuada da fase esquizoparanóide ao longo da vida, Souza (2009, p.55) coloca:



Essa linguagem técnica talvez dê a impressão de algo muito distante de nosso cotidiano, do mundo dos outros, dos loucos, e não uma experiência à qual estamos sujeitos com muita frequência. Mas o que Klein tenta descrever é algo de nosso dia-a-dia. Ela se refere àqueles momentos nos quais parecemos ficar cegos para o que sentimos e para quem é o outro e o que ele está sentindo. Tomados de emoções avassaladoras, somos ou dom-quixotes iludidos pela idealização ou tiranos convencidos da pertinência e da propriedade de nosso sadismo, diante da impossibilidade de aceitar que podemos ser frustrados. É possível superarmos essas vivências e aprender com elas ou passar a vida lutando contra inimigos imaginários.

Sigamos, então, o que emerge da posição esquizoparanóide: a posição depressiva.

EDUCACIONAL

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE ENTENDER O PENSAMENTO KLEINIANO

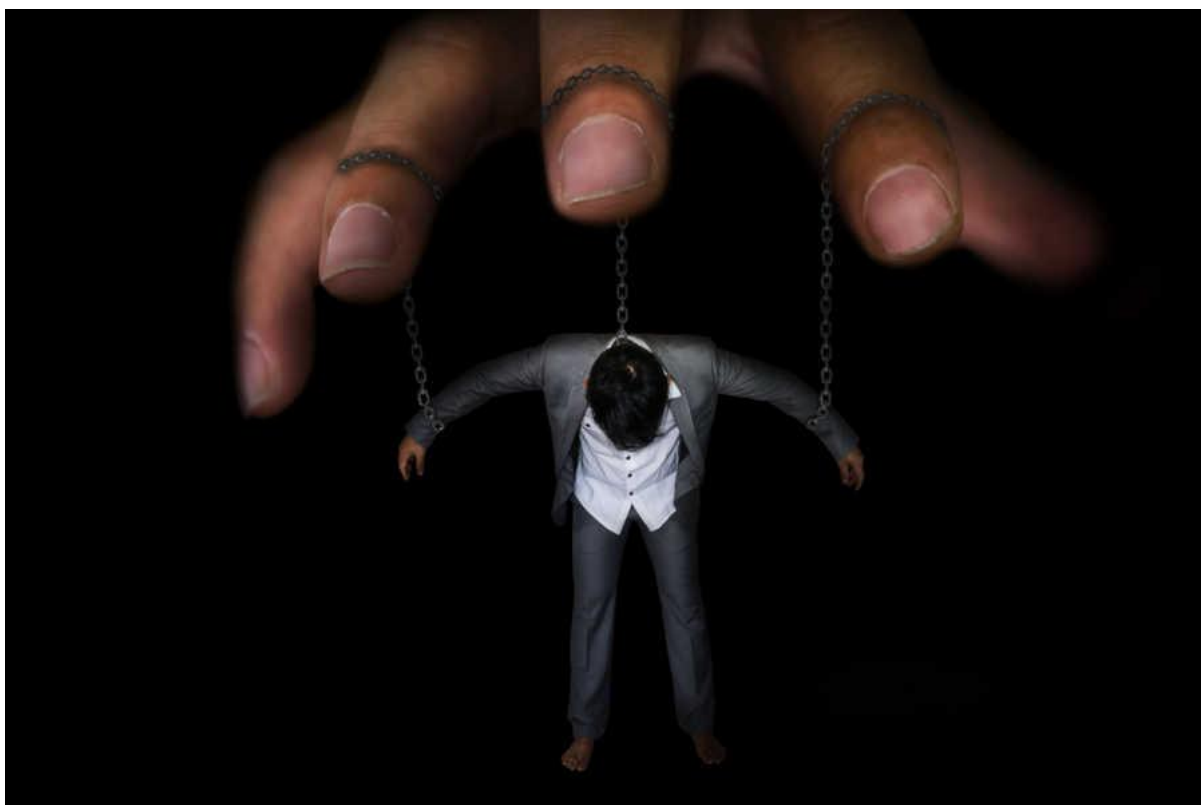
UNIDADE 4 | CAPÍTULO 3Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

A posição depressiva



1

introdução

Segundo Segal (1973), a posição depressiva, para Melanie Klein representaria o momento do desenvolvimento no qual o bebê reconheceria um objeto total e estabeleceria, por essa via, novas formas de relação objetal. Acompanhemos então, como Klein descreverá a posição depressiva em dois importantes escritos: Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivo, de 1935, e Algumas Conclusões Teóricas sobre A Vida Emocional do Bebê, de 1952.

De acordo com a psicanalista, a partir do segundo trimestre do primeiro ano, o bebê começa a atravessar algumas transformações intelectuais e emocionais que o levam a uma modificação em sua relação com o mundo externo. Seus interesses se ampliam – e, conseqüentemente, também suas gratificações. Aumentam, ainda, suas capacidades de expressar emoções para os outros. Enfim, ocorre uma gradual integração e um gradual fortalecimento das funções do ego.

Nesse processo, a organização sexual da criança também vai se modificando, com uma intensificação das tendências uretrais, anais e genitais. Diferentes fontes de impulsos libidinais e agressivos passam a fazer maior presença na já agitada vida emocional do bebê, ampliando o campo das fantasias – que, agora, já assume feições mais elaboradas – e desencadeando novas situações de ansiedade. O correlato será um desenvolvimento também na natureza das defesas.

Na proporção em que o ego se torna mais organizado, vai ocorrendo uma aproximação entre os objetos internos e os objetos externos. Vimos que a repetição continuada de introjeções e projeções dos objetos auxiliam no desenrolar desse processo. E ele propiciará uma identificação mais completa do ego com os “bons” objetos, o que vai fazendo surgir um ego

mais fortalecido, mais preparado para lidar com o medo dos “maus” objetos e com a ansiedade persecutória. É nesse contexto que o bebê vivenciará uma mudança fundamental em seu psiquismo. Relata Klein (1935/1996, p. 306):



Juntamente com esse desenvolvimento ocorre uma mudança da maior importância: a passagem de uma relação de objeto parcial para a relação com um objeto total. Ao dar esse passo, o ego atinge nova posição, que serve de base para a situação chamada de perda do objeto amado. Só quando o objeto é amado como um todo é que sua perda pode ser sentida como um todo.

Necessário ressaltar aqui que os mecanismos que fazem com que o objeto se torne total ocorrem simultaneamente àqueles que levam a uma cada vez maior integração do ego. Teremos, portanto, agora relações objetais que se travam entre um ego cada vez mais coeso e um objeto total. Essa é a marca precípua da posição depressiva. Ela tem implicações fundamentais na vida psíquica, porque, quando ao mesmo tempo em que o bebê reconhece sua mãe como objeto total, ele também percebe que é ela a fonte tanto de suas boas experiências como também das más. Da mesma forma, a integração de seu ego o leva a perceber que é ele quem direciona a mãe não apenas os sentimentos bons, mas também os destrutivos.

Importante

Importante ressaltar que esses desenvolvimentos se dão inicialmente com relação à mãe, pela transposição gradual da condição de seio para a de pessoa, objeto completo com quem o bebê se identificará. Nesse mesmo contínuo, no entanto, farão entrada o pai, o casal, e outras pessoas de relevância para o bebê.

É essa mudança, que estamos fazendo questão de bem demarcar, que operará uma transformação na faceta da ansiedade quando ocorre a entrada na posição depressiva, moldando, igualmente, novas configurações para os mecanismos de defesa. É como Klein (1952/1986, p.230) esclarece:



Todos esses processos de integração e síntese fazem que o conflito entre amor e ódio atinja sua plena força. A consequente ansiedade depressiva e os sentimentos de culpa alteram-se não só em quantidade, mas também em qualidade. A ambivalência é agora experimentada, de modo predominante, em relação a um objeto completo. Amor e ódio estão muito mais unidos, e o seio “bom” e “mau”, a mãe “boa” e “má”, já não podem manter-se tão separados quanto no estágio anterior.

A ambivalência, portanto, será um forte vetor de ansiedade. O bebê percebe que, quando libera em suas fantasias seus impulsos sádicos e destrutivos, tem como alvo justamente o objeto que ama e que teme imensamente perder – o objeto de onde retira elementos para fortalecer o seu ego e enfrentar seus medos. Essa nova configuração também trará uma alteração nas interações entre introjeção e projeção. E de que forma?

Quando as condições de desenvolvimento são favoráveis, o bebê percebe cada vez mais robustez em seu objeto ideal e os impulsos libidinais, que ficarão aumentados, também o fortalece na queda de braço contra os impulsos agressivos e os maus objetos. Essa dinâmica favorece a que ele se identifique com o objeto ideal e se torne mais apto para se defender e para sentir que pode defender o objeto amado de seus próprios impulsos maus. Confiante em sua capacidade de lidar com os próprios sentimentos negativos, ele necessita cada vez menos fazer uso da projeção, pois sua tolerância ao instinto de morte que atua dentro de si e, conseqüentemente, aos seus medos persecutórios aumenta. É um círculo de reforço que favorece a integração do bebê: "Quando diminui a projeção de impulsos maus, diminui também o poder atribuído ao objeto mau, ao passo que o ego se torna mais forte, já que está menos empobrecido pela projeção". (SEGAL, 1973/1975, p. 80)

Concomitantemente, na medida em que os anseios libidinais aumentam por decorrência de uma identificação mais completa com o objeto bom, a criança desenvolverá um amor e um desejo voraz por incorporar esse objeto, intensificando o mecanismo de introjeção. "Nesse estágio, mais do que nunca, o ego é impelido pelo amor e pela necessidade de introjetar o objeto". (KLEIN, 1935/1996, p.306). Mas, além de possuí-lo, a criança também deseja protegê-lo, acreditando que, ao trazê-lo para dentro de si, o manterá a salvo de perigos. Essa intensificação da introjeção atuará como já mencionamos, na integração do ego.

Porém, a mesma dinâmica que favorece a integração do ego também está na origem das ansiedades depressivas. Isso porque o indivíduo passa a perceber o valor que o objeto possui para ele, havendo um significativo aumento da consideração que ele nutre pelo objeto. O indivíduo passa então a experimentar o medo da "perda do objeto amado", assim como se da conta também de sua dependência com relação a este objeto. A descoberta da ambivalência faz com que ele experimente intensos sentimentos de anseio, culpa e luto com relação tanto aos objetos internos como externos.

Teme, então, que seus próprios impulsos destrutivos danifiquem o objeto amado, assim como receia a ação dos objetos persecutórios internalizados sobre ele. O medo de que o objeto esteja passando por um perigo de aniquilamento ou já tenha sido aniquilado gera uma identificação ainda mais forte com o objeto danificado, e se encontra na base das tentativas que o ego fará para reparar o objeto de amor.

Além disso, o ego também fará uso das defesas maníacas. Novamente vemos surgir aqui os mesmos mecanismos que tomaram a cena na posição esquizoparanóide: a negação, a idealização, a clivagem, a identificação projetiva e a busca pelo controle dos objetos são mais uma vez usados pelo ego – só que, agora, de forma qualitativamente diferente. Eles buscam neutralizar as ansiedades depressivas e a culpa, e são muitíssimos mais organizados do que na fase anterior, em concordância com o estado de maior integração do ego.

As defesas maníacas tentarão, portanto, neutralizar as marcas da experiência depressiva. Voltam-se, por exemplo, para a dependência que o ego percebeu ter com relação ao objeto amado, contrapondo-se a esse sentimento, que será obviado, negado ou invertido. Há também tentativas de negar o amor pelo objeto, o que poderá resultar em uma duradoura sufocação do amor, com um distanciamento dos objetos ideais e um retorno a ansiedade persecutória, pois restariam apenas os maus objetos.

A defesa maníaca que intenta o controle dos objetos deriva dos sentimentos de onipotência e é usada tanto para tentar conter a ação dos objetos internos malignos contra o objeto amado

como para evitar as frustrações que podem advir inclusive desses objetos ideais. A clivagem, por sua vez, tem agora outro resultado. Ela divide o objeto completo em um objeto vivo e imune de riscos em detrimento de um objeto danificado e em perigo. Tenta, assim, preservar o objeto amado.

Segal (1973) e Nazio (1995) ressaltam, ainda, que mais duas formas de defesa próprias a posição depressiva: o triunfo e o desprezo. Ambas estariam ligadas com a percepção do valor do objeto amado, com o medo de perdê-lo e com a culpa por qualquer dano que pudesse ser a ele causado.

No triunfo, a fantasia é a de dominação do objeto, a de sua humilhação e tortura. Ora, essas tendências voltam-se contra os objetos persecutórios, ora contra os objetos idealizados. No caso desses últimos, propicia-se uma derrocada de seus aspectos louváveis, buscando com isso diminuir a dor causada por uma possível perda dos objetos amados – esse mecanismo está relacionado com a vivência da inveja).

No desprezo, o movimento é por uma desvalorização do objeto, por uma tentativa de diminuir a importância que ele possui para o indivíduo, desqualificando-o e o considerando desprezível ao ponto de não ser digno de despertar culpa.

Nazio (1995) cita também as defesas pela fuga. Trata-se de uma fuga para os bons objetos. Se ela se direcionar para os objetos internos, tem-se um distanciamento da realidade (psicoses, autismo). Se ela ocorrer no sentido dos objetos externos, tem-se os estados amorosos repetitivos nas neuroses. De uma forma ou de outra, o indivíduo evita lidar com as ansiedades desencadeadas pela perda do objeto amado.

Por fim, há ainda uma defesa maníaca importante de ser comentada. Ela precisa ser tratada com atenção porque se trata de um mecanismo que não obrigatoriamente se constituirá como defesa. Pode ser, ao contrário, uma das formas positivas de elaboração da posição depressiva. Estamos falando do processo de reparação.

Quando o bebê passa a perceber a mãe como objeto total, ele começa a experimentar também a intensa ansiedade de ter de lidar com o fato de que ela é uma pessoa diferenciada dele, e possui desejos e mobilidade próprios diversos dos seus. A mãe pode desaparecer por horas a fio e, depois, retornar, não exercendo o infante nenhum controle sobre os destinos desse tão fundamental objeto. Isso causa uma miscelânea de sentimentos – raiva, tristeza, medo – que, agora, ele já reconhece como sendo seus.

Esse conjunto de sofrimentos advém da crença do bebê de que, quando a mãe some, ele pode tê-la perdido para sempre. Ela pode não mais voltar, pois pode ter sido danificada ou até mesmo morta – quem sabe em consequência dos sentimentos sádicos e agressivos que um dia o bebê lhe direcionou. Essas idéias não só desencadeiam ansiedades depressivas, como também geram no pequeno indivíduo fortes sentimentos de culpa.

No entanto, o bebê será exposto repetidas vezes a essas experiências de perda, assim como repetidas vezes experimentará a recuperação do objeto. O retorno da mãe, juntamente com o contínuo amor e cuidado recebidos do ambiente, faz com que ele vá gradativamente percebendo que os ataques sádicos e agressivos que realiza em suas fantasias não têm a onipotência para destruir os objetos amados na realidade. Dessa forma, vai ganhando mais confiança na força de seus impulsos amorosos e em sua capacidade de, após as manifestações de raiva e desagrado, restaurar seus objetos internos e mantê-los consigo nos

momentos de ausência dos objetos externos. Seu ódio torna-se menos assustadores, e as ansiedades depressivas vão perdendo a força. Como bem ressalta Segal (1973/1975, p. 105)



Por meio da repetição de experiências de perda e recuperação, sentidas parcialmente como destruição pelo ódio e recriação pelo amor, o objeto bom se torna gradualmente mais bem assimilado no ego, pois, na medida em que o ego restaura e recria o objeto internamente, este se torna cada vez mais propriedade do ego, podendo ser assimilado por ele e contribuir para seu crescimento.

Mas nem sempre será esse o caminho assumido pelo processo de reparação. Tal mecanismo pode se desenrolar dentro de um contexto em que o bebê ainda esteja tomado pelo sentimento de onipotência e não encontre um ambiente que favoreça a aproximação de suas fantasias da realidade externa. Isso dificultará a adequação da realidade psíquica, interferindo no crescimento do ego e a adaptação deste à realidade. Nesse caso tem-se a reparação como uma defesa maníaca, usada para evitar qualquer contato com os sentimentos de perda e de culpa.

Uma das formas de realizar esse intento é, por exemplo, realizando uma substituição do objeto. Ao invés de buscar reparar o objeto de amor, os esforços de reparação são direcionados para objetos remotos, que tenham sofrido danos por causas igualmente remotas e impossíveis de serem relacionadas a ações ou sentimentos do indivíduo.

Há que ser também um objeto, em certa medida, desprezível. Inferior ao sujeito que se entrega ao ato de reparação – para que não haja o risco de que esse objeto substituto desperte justamente os sentimentos amorosos que se tentou evitar no objeto original. Tal artimanha faz com que a reparação maníaca nunca consiga realizar o intento de restaurar, de fato, o objeto que escolhe. Porque isso faria dele um objeto de amor, o que levaria novamente à emergência do medo da perda deste objeto e à ansiedade que o acompanha e que tanto se tentou evitar por meio da reparação. Segal (1973/1975, p. 109) conclui:



Por causa dessas condições, a culpa subjacente que a reparação maníaca procura aliviar não é, na verdade, aliviada, e a reparação não traz satisfação durável. Os objetos que estão sendo reparados são tratados inconscientemente – e às vezes conscientemente – com ódio e desprezo, sendo invariavelmente sentidos como ingratos e, pelo menos inconscientemente, temidos como perseguidores potenciais.

O que pode se observar, portanto, é que a reparação que conduz à uma saída positiva da posição depressiva não tem como dispensar o reconhecimento de uma perda do objeto. Apenas o reconhecimento e a aceitação dessa perda é que permitem a elaboração da culpa por meio da recriação de um novo objeto interno. Isso nos leva a compreender porque a única superação verdadeira da posição depressiva se dá por meio do trabalho do luto. “É do resultado do trabalho de luto do objeto primordial que depende a saída da neurose infantil e da neurose transferencial”. (NAZIO, 1995, p. 163) Sobre isso, Nazio (1995, p.163) acrescenta ainda:



Para Melanie Klein, todo luto que ocorre posteriormente na vida reaviva a posição depressiva, isto é, tem um episódio confusional, ativado pelas angústias persecutórias e pelos sentimentos de ódio, desespero e saudade. A nostalgia, isto é, a memória do “bom” objeto, é o estímulo para o trabalho do luto. Somente o amor pelo objeto, e não o ódio garante o processo. Nesse estágio do luto, o sofrimento pode tornar-se produtivo, e não mais inibidor. A reconstrução do mundo interno caracteriza então o sucesso do trabalho do luto.

Conclui-se assim que a capacidade que a criança vai adquirindo para lidar com a ansiedade depressiva está diretamente relacionada com a forma como ela conseguiu incorporar e estabelecer o seu bom objeto, base para o núcleo do seu ego. Sendo esse processo bem sucedido, a criança superará a posição depressiva e estará pronta para enfrentar os desafios do complexo de Édipo, agora lidando com objetos completos e com os sentimentos ambivalentes que carrega em relação a eles. Contudo, se o ego não aprender a bem manejar as situações de ansiedade da posição depressiva, ele correrá o risco de regredir à posição esquizoparanóide, o que “impediria também os processos de introjeção do objeto completo e afetaria substancialmente o desenvolvimento não só durante o primeiro ano de vida, mas em toda a infância” (KLEIN, 1952/1986, p. 235) e também na vida adulta.

Encerramos aqui nossa exposição dos mais básicos e originais desenvolvimentos teóricos com os quais Melanie Klein prestou sua contribuição ao pensar psicanalítico. Sua obra influenciou de forma indelével a maneira de conceber o psiquismo infantil, assim como ampliou as possibilidades de sua técnica psicanalítica, ao criar a análise lúdica. Assim como na primeira parte deste guia de estudos, acreditamos ter feito um recorte dos conceitos kleinianos que constituirá um preâmbulo consistente para situar e incentivar àqueles que pretendam enveredar pelo pensamento de Klein – percurso que constitui uma das mais fascinantes buscas de compreensão da psique humana.

2

Conclusão

É hora de concluirmos nosso percurso. Desejamos fechar esta nossa caminhada ressaltando que a psicanálise é um saber vai além de uma ferramenta clínica. Seu lugar no campo ‘*psi*’ é marcado por essa constante busca do Inconsciente, compondo-se como um discurso que não visa a cura, no sentido médico do termo é que busca escapar dos usos que buscam objetivos adaptacionistas.

A psicanálise, no mundo em que vivemos - o mundo da pressa, da eficiência, das ideias avassaladoras de sucesso e de felicidade – continua a se apresentar como contracorrente de pensamento. Ela nos ajuda a deitar um olhar crítico sobre os fenômenos psicossociais e a compor espaços de resistência discursiva que permitem ao homem assumir seu mal-estar e elaborá-lo, dando-lhe palavras. Que esse seja apenas um início de percurso dentro desse campo desafiador.